*Événementiel*

# Le « courage » de guérir

*Alain Morau*

**« *Il vaut mieux mourir selon les règles, que de réchapper contre les règles.* »**
**Précepte de Molière dans : *L'amour médecin*, acte II, scène 5.**

« *Nous sommes en guerre* », répéta Emmanuel Macron à six reprises, dans son allocution au sujet de la pandémie du covid-19, le 16 mars 2020 : « J'appelle tous les acteurs en politique, économie, de l'ensemble du système social et associatif à s'unir à cette union nationale qui a permis à notre pays se surmonter tant de crises dans le passé. »[1] Les Français avaient déjà entendu ces mêmes paroles en 2015/16, lorsque son prédécesseur François Hollande, à l'occasion de l'attentat de Paris, déclara une « guerre contre le terrorisme », qui devant justifier l'état d'urgence [et aussi un état juridique « d'exception », *ndt*] qui devait régner jusqu'en 2017. À partir de cette expérience et d'autres, il nous faut être particulièrement vigilants lorsque de telles expressions militaires sont employées dans des crises. Elles visent en général à conclure une « *union nationale* »[2] avec les gouvernants, de sorte que leur politique soit menée sans résistance.

Cette sorte de soutien illimité, Macron en avait aussi besoin cependant car il annonça aussi quelque chose qui eût été encore complètement inimaginable peu avant : un confinement[(*)] total à domicile. Conformément à cela, le jour suivant, la liberté personnelle de déplacement en France se vit fortement limitée, dans une mesure bien plus sévère qu'en Allemagne. La population ne fut dès lors autorisée à quitter son domicile que sous des conditions strictes et dans de nombreuses villes un couvre-feu nocturne fut même décrété. En riposte, Macron promit un soutien sans réserve pour les médecins et soignants. Cela n'allait guère plus loin. Depuis mars 2019, déjà, les infirmières et infirmiers avaient manifesté et faisaient grève pour dénoncer les restrictions budgétaires et les conditions de travail dégradées dans les hôpitaux et nonobstant leurs revendications n'avaient pas été entendues et que leurs avertissements étaient restés ignorés. Cela étant les informations s'accumulèrent sur le manque dramatique de masques et tenues de protection et moyens de désinfection dans les hôpitaux, dans les cabinets de consultation médicale et les EHPAD. L'opinion publique indignée apprit dans le même temps que les réserves stratégiques en la matière s'étaient volatilisées au fil des ans pour des raisons de mesures économiques.[3]

En outre des tests firent défaut. Dès le début en France on effectua fondamentalement et nettement moins de tests qu'en Allemagne. Bien que le gouvernement, dès la fin de mars, eut la capacité de réaliser jusqu'à 12 000 tests par jour, le nombre de tests resta nettement essentiellement bien moindre qu'en Allemagne. Officiellement, on déclara : « Les tests ne servent pas la mesure, mais plutôt l'endiguement de l'épidémie. […] Il n'y a aucun droit à se laisser tester et il n'y pas d'utilité particulière pour la population générale à se laisser tester. […] Avec l'accroissement du nombre des cas, la recherche systématique des personnes avec lesquelles on fut en contact est devenue superflue ».[4] Les tests furent donc principalement réservés aux patients présentant de graves symptômes qui se trouvaient déjà hospitalisés pour la plupart. Toutes les autres devaient donc rester confinées chez elles — sans savoir si elles étaient réellement infectées ou non et étaient susceptibles d'infecter leur famille. Si un malade légèrement atteint était exceptionnellement testé et déclaré infecté, il devait rester chez lui en quarantaine et attendre de voir comment évoluerait son état. Le traitement recommandé fut purement et simplement du paracétamol contre la fièvre. Seulement si le cas s'aggravait cela menait exceptionnellement à l'hospitalisation.

Cette stratégie ignorait donc systématiquement les malades au stade précoce : On ne tenta ni de les reconnaître, ni de leur venir en aide et on attendit passivement l'afflux de patients gravement atteints, sans

---

[1] www.achgut.com/artikel/corona_text_der_rede_von_emmanuel_macron_auf-deutsch

[2] Pendant le première guerre mondiale, on parla en France d'une *union sacrée*.

[Celle-ci est un fait historique qui a permis entre autres de museler la presse en instaurant la censure totale sur toute la presse à ce moement-là, d'où en 1915, en pleine guerre, la création du ***Canard Enchaîné*** par Jeanne et Maurice Maréchal, pour résister aux mensonges de la presse autorisée. Ce journal est toujours le seul et unique organe de presse réellement indépendant en France depuis ce temps dont la devise est « *La liberté ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas* », une devise qui eût plu à Rudolf Steiner le grand enseignant de la liberté spirituelle. *Ndt*]

**(*)** Que certains maires se sont empressés d'ailleurs interpréter unilatéralement « à la lettre » de l'expression allemande ici employée : d'*Ausgangsperre* comme un véritable et effectif « couvre-feu ». Remarquez bien que cela n'a pas empêché un million de Parisiens de prendre le chemin des écoliers pour aller se confiner en province, bref une atmosphère qui rappelle l'an 40 du siècle passé, d'autant que celle-ci s'est vue bientôt confirmée par les dénonciations spontanées à la police de contrevenants à l'obligation impérieuse de rester à domicile par les voisins attentionnés comme aux « beaux jours » de la collaboration avec les nazis. Ce qui confirme encore, si besoins en tait, la profonde césure régnant toujours dans le pays depuis cette époque. *Ndt*

[3] Voir : www.neues-deutschland.de/artikel/1134968.warum-masken-mangelware-wurden.html [*Pourquoi les marques devinrent une denrée rare*] [Depuis plusieurs années un plan de diminution des lits d'hospitalisation a été systématiquement poursuivi en France ; de plus nos grands centres hospitaliers de pointe bien équipés, ne se trouvent absolument plus accessibles lors des pandémies, car ils sont désormais paralysés par les besoins de réanimation. On se posera peut-être la question plus tard mais pourquoi les crises cardiaques et les AVC ont-ils subitement diminué ? Parce que désormais la gens ont peur d'aller à l'hôpital.. ? La peur n'a certes jamais évité le danger, mais elle peut s'avérer salutaire. *Ndt*]

[4] www.gouvernement.fr/info-coronavirus  « Dépistage » (consulté le 3 avril 2020).

entreprendre quelque chose de prophylactique. Pour le gouvernement, la seule question qui se posait c'était celle de savoir comment les postes de réanimation pouvaient parer à l'afflux attendu de malades. Pour éviter leur surcharge, on agit sur deux leviers : le renforcement des ressources et le ralentissement de cet afflux en nombre. Selon l'ex-ministre de la santé, Agnès Buzyn, le gouvernement avait déjà été parfaitement informé du caractère de gravité de la situation dès la fin janvier.[5] Pourtant on ne constitua pas de stocks, ni on ne mit fin immédiatement à la diminution des postes de réanimations. Le gouvernement n'a donc imposé que le confinement total à domicile avec une résolution conséquente. Pourquoi donc précisément cette stratégie fut-elle suivie ? Au point où nous en sommes, des réponses à cette question ne peuvent être que spéculatives. Mais la société française paye un prix élevé pour celle-ci de sorte que la question se pose de savoir quel genre de « guerre » est à proprement parler en cours ici. Des pays comme l'Allemagne ou même carrément la Suède, révèlent nonobstant comment avec bien moins de restrictions drastiques de la vie sociale, la situation peut se voir contrôlée.
Malgré l'appel à « l'union nationale » critiques et doutes apparurent bientôt. Le 22 mars s'accomplit un acte d'insubordination carrément luthérienne au moment où la direction du département de virologie de l' *Institut Hospitalo-universitaire Méditerrannée Infection [IUHMI]* de Marseille annonça : « En accord avec le serment d'Hippocrate, que nous avons cautionné, nous obéissons à notre devoir de médecins. Nous offrons à nos patients les meilleurs soins possibles lors du diagnostic comme du traitement d'une maladie. Nous respectons les règles de l'art et les plus récentes données de la science médicales ».[6] On déclara que désormais pour tout malade exhibant les symptômes correspondants devait être testé cliniquement au covid-19. Comme traitement était prescrite une combinaison d'un médicament contre la malaria, l'hydroxychloroquine (HCQ) associée à l'antibiotique azithromycine. Une étude parue deux jours auparavant avait montré sur un petit groupe de 36 malades qu'après six jours, 87,5% du groupe de contrôle de ceux non-traités portaient encore le virus. Ce pourcentage tombe à 43% pour ceux traités à l'HCQ, et chez ceux traités par la combinaison HCQ-azithromycine, à 0%.[7]

***Problèmes méthodologiques***

La chloroquine — et sa substance dérivée d'une meilleure tolérance l'HCQ — est un médicament employé contre la malaria qui fut développé en 1934 par *IG Farben* et employé aussi dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux systémique. Étant donné que la protection du brevet est échue, il est relativement peu cher. Dès la fin de février, Didier Raout, directeur de l'IHUMI, avait renvoyé aux résultats récents de chercheurs chinois, qui avaient rapporté une action de l'HCQ contre le covid-19. Sa manière de voir s'appuyait sur celle du traitement de l'infection au virus HIV : « Comment le SIDA fut-il mis sous contrôle ? Ceci ne se produisit pas par la vaccination ni par des modèles mathématiques. On visa à faire baisser la charge virale. Lorsqu'elle passe sous un certain seuil, les êtres humains ne sont plus infectés et ne sont plus malades. C'est le modèle que nous tentons d'établir. »[8] Donc, pour éviter des dommages au système pulmonaire, on tente de réduire la pression virale du covid-19 au stade **précoce** de la maladie [Soulignement en gras du traducteur].
Bien que Raoult appartienne aux experts les plus considérés de sa spécialité[9], le ministère de la santé et d'autres spécialistes se sont exprimés par des refus ou des réserves. Le même jour où l'IHUMI publia sa première étude clinique, les académies nationales de médecine et de pharmacie, dans un communiqué de presse commun affirmèrent « que l'efficacité clinique de l'HCQ sur la base des connaissances scientifiques actuelles n'était pas prouvée »[10]. Une semaine après, le Collège Nationale des généralistes Enseignants (CNGE) déclara le défaut méthodologique de l'étude : le manque de randomisation, d'analyse en double aveugle et de contrôle par placebo ; la comparabilité incertaine des deux groupes : le choix de la charge virale comme critère, ce qui ne suffit pas pour être corrélé aux complications cliniques ; et une analyse statistiquement contestable : « L'urgence et de démesure de la pandémie ne permettent aucun abandon des principes et exigences fondamentaux de l'essai clinique thérapeutique. […] Eu égard à l'absence de preuves scientifiques consistantes de l'efficacité de l'HCQ et de ses rares, mais graves effets secondaires, le CNGE recommande que les médecins généralistes ne doivent pas prescrire ce médicament. Une telle prescription se heurterait à l'éthique médicale, puisque le risque (connu) est potentiellement plus grand que l'efficacité (non

[5] https://taz.de/Corona-Pandemie-in-Frankreich/!5672275/
[6] www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronavirus-covid-19/
[7] Phlippe Gautret *et al.* : *Hydoxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19 : results of an open-label non-randomized clinical trial [HCQ et azithomycine comme traitement du COVID-19 : résultats d'un essai clinique ouvert non randomisé]* — doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.1059496
[8] www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc à 1min 22.
[9] http://expertscape.com/au/infectious+diseases/Raoult%2C+D
[10] www.academie-medecine.fr/wp-content/

prouvée) dans une population ambulante qui guérit spontanément à plus de 80% des cas. »[11] Cette institution et d'autres de la médecine et de la science réclament donc l'observation de ces critères-là qu'aujourd'hui on identifie — de manière erronée — à ce qu'on appelle l'*Evidence based Medicine (EbM- Médecine fondée sur la preuve évidente)*.[12]
Dans diverses *interviews* et articles, Raoult refuse l'exigence d'une validation par des études randomisées, en double aveugle et contrôlées par placebo avec le plus grand nombre possible de patients. D'une part il est éthiquement problématique de fournir des placebos aux malades dont la vie est menacée. Mais ceci n'a pas non plus de justification épidémiologique : « Dans l'histoire des maladies infectieuses, cette méthode fut à peine jamais utilisée comme preuve d'efficacité d'un remède. La raison en est que lors des maladies infectieuses, il est extrêmement facile de mesurer la disparition du microbe. » C'est ce que montre le virus-HIV : « Chez les malades du SIDA, c'était précisément simple. Lorsque nous avions un traitement efficace, nous savions cela chez trois patients. Le virus n'était plus dans le sang. Avec cela il était passé. Il n'y a lus aucun besoin de faire ce genre d'études sur mille personnes. » La dominance de l'*EbM* — mal comprise — est devenue selon Raoult un problème fondamental : « Il existe en effet des gens qui ne sont ni scientifiques, ni praticiens, dont la mission est d'exercer une sorte de contrôle sur les travaux des autres. […] Or cela est devenu un processus extrêmement difficile, lors duquel nous oublions à la fin que l'unique chose importante en médecine, c'est l'efficacité. C'est la méthode qui doit s'adapter au problème et non pas le problème à la méthode. »[13]

***Statistiques ou empirisme ?***
En ce qui concerne la question des effets secondaires, Raoult mentionne que les médicaments contestables sont largement répandus et bien connus : « Aux Etats-Unis, en un an, un être humain sur huit utilise l'azithromycine et plus d'un milliard d'êtres humains ont absorbé de la chloroquine. »[14] La tolérance est généralement bonne, lorsque la dose est correcte, les contre-indications prises en compte et les contrôles nécessaires effectués. Des médicaments avec la chloroquine ont été en accès libre de longues décennies durant, jusqu'à ce que le ministère français de la santé en déclarât la vente conditionnée à une ordonnance médicale, le 13 janvier 2020 (le décret avait déjà été mis en route à l'automne 2019).[15]
Du 23 au 27 mars parurent trois décrets du ministère de la santé se contredisant les uns les autres, mais qui soutinrent en définitive la position du CNGE. Laquelle interdit aux médecins en cabinet de prescrire de l'HCQ et en limite l'usage aux centres hospitaliers pour des patients aux stades avancés de la maladie — et donc seulement lorsque c'est trop tard, selon Raoult.[16]
Cette décision fut défendue par de nombreux experts et critiquée par d'autres. Dans le journal conservateur ***Le Figaro*** trois anciens directeurs d'institutions dirigeantes du système de la santé publièrent un appel à soutenir les préconisations du Pr. Raoult[17], et le professeur Philippe Douste-Blazy et la Dr. Michèle Barzac, deux anciens ministres de la santé, ainsi que le Pr. Christian Perronne de la clinique universitaire de Garches lancèrent une pétition pour rendre « l'HCQ accessible sans délai dans toutes les pharmacies »[18], et rencontrèrent à la mi-avril plus d'un demi million de soutiens.
Il s'agit donc d'un conflit entre deux écoles de pensée : l'une s'appuie sur des statistiques et l'autre sur l'empirisme. Et l'empirisme peut produire des succès. Le 4 avril l'IHUMI publia les résultats d'une étude nouvelle englobant 1061 patients cette fois, qui montra une guérison chez 91,7% d'entre eux et un taux de mortalité de 0,75% et ainsi qu'aucunes complications d'effets secondaires.[19] Depuis la fin mars, le nombre actuel des patients traités par l'HCQ et l'azithromicine est publié sur *Internet* avec à côté le taux de mortalité. Le 20 avril on en était respectivement à 2970 et à 12, ce qui montre un taux de mortalité de 0,4%.[20] Tout

[11] www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_y_a_t_il_un_place_pour_lhydroxychloroquine/
[12] Combien de manière strictement réductionniste l'*EbM* est aujourd'hui considérée, c'est ce que révèle un texte de base déterminant dans lequel il est affirmé que celle-ci « n'est pas limitée par des études et des méta-analyses randomisées contrôlées », mais signifie plutôt « l'intégration individuelle d'expertise clinique avec les preuves extérieures les plus disponibles extraites de la recherche systématique. » Ce qui vaut à cette occasion c'est ceci : « Des preuves cliniques externes peuvent certes complèter l'expérience clinique, mais ne peuvent jamais la remplacer. » — www.cochrane.de/de/sackett-artikel
[13] *Interview* du 1er avril 2020 dans l'émission *Esprits libres,*
[14] www.youtube.com/watch?v=GfkUnJ46MV1 à 2 min 30.
[15] Voir www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400024&categoriLien=id
[16] Voir www.lemediapourtous.frmarche-arrierefinalement-la-chloroquine-ne-sera-utilisee-que-dans-les-cas-graves/
[17] www.lefigaro.fr/vox/societe/chloroquine-1-appel-de-trois-grands-noms-de-la-sante-en-faveur-des-preconisations-du-pr-raoult-20200405
[18] www.change.org/p/ephilippepm-traitement--covid19-ne-perdons-plus-de-temps-neperdonsplusdetemps
[19] www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/MS.pdf
[20] www.mediterranee.infection.com/covid-19

ceci va dans le sens du principe empirique de Raoult : « Ce qui est important en médecine, c'est l'efficience. »[21] — Celui qui guérit a donc raison.

***La discussion va plus loin***

Dans un sondage représentatif, 35% des Français déclaraient au début d'avril qu'ils tenaient la chloroquine pour un remède efficace contre le covid-19, 6% soutenait le contraire, 53% restaient indécis, et 7% n'en avait encore jamais entendu parler.[22] Étant donné que le gouvernement ne peut plus ignorer un tel tableau de voix, il en est arrivé, le 9 avril, à une visite surprenante de Macron à l'IHUMI. Son discours suivant à la nation ne fit pas reconnaître de changement substantiel quant au confinement à domicile ainsi qu'au sujet du traitement médical de l'infection au covid-19. Pour le président il s'agissait alors seulement de se montrer moins confrontatif dans sa stratégie communication.

En d'autres lieux aussi il y eut des débats sur le chloroquine. Après que le président US Donald Trump eut loué les méthodes de l'IHUMI, les autorités médicales de la FDA édictèrent une autorisation d'urgence pour la chloroquine en clinique.[23] Mais en Russie aussi, de larges régions d'Asie, d'Afrique et des pays latino-américains, en Belgique et dans les Pays-Bas, au Portugal, en Italie et Israël, l'HCQ est recommandée.[24] En Suisse, les hôpitaux universitaires de Lausanne et de Genève traitent respectivement 40 % et 50% de leurs patients covid-19 avec la chloroquine.[25] En Chine plus de 20 études ont té initiées sur l'HCQ, à l'occasion de quoi l'étude randomisée confirme son efficacité.[26] Le consortium pharmaceutique *Bayer* veut lancer en Europe la production de substance active et a importé 600 000 tablettes en Allemagne dont le ministre fédéral de la santé, Jens Spahn, fit réserver une « plus grosse quantité ».[27] Au début d'avril un sondage effectué auprès de 5000 médecins, dans 30 pays, révéla que 44% utilisent l'HCQ pour le traitement de l'infection au covid-19 et 38% la caractérisent comme « très ou extrêmement » efficace. Ceux de la Chine, de l'Espagne, de la France et en particulier de l'Italie se trouvaient à la pointe.[28]

Même la Chambre fédérale des médecins (*Bundesärztekammer — BÄK*) la commission des remèdes de l'Association médicale allemande (*deutsche Ärzteschaft — AkdÄ*) déclarèrent pragmatiquement le 6 avril, « qu'une évaluation fondée sur des preuves en vue de la non-autorisation, ou le cas échéant de non-prévention ou non-traitement de la maladie causée par le SARS-CoV-2, pour juger de sa qualité, de son efficacité et de son caractère inoffensif ne sera possible que dans un très petit nombre de cas. […] Étant donné que très peu de données d'études seulement sont disponibles, lors de l'évaluation de la relation entre risques et utilité, le recours à l'expérience clinique doit être nécessairement réalisé de manière empirique. »[29]— Mais dans le même temps, la ***Suddeutsche*** et la ***Frankfurter Allgemeine Zeitung***, sous les manchettes tendancieuses : « *Mauvais conseil du Président* » et respectivement « *Pari dangereux de Trump sur un remède miracle* » rapportèrent sur la chloroquine redonnant, sans se laisser déconcerte avec cela, le consensus des médias directeurs allemands.[30]

Totalement et indépendamment de cela, quelques perspectives qu'offrent la Chloroquine dans cette crise à longue échéance, la discussion est symptomatique quant la manière unilatérale de s'y prendre des médias, de la politique et de la science concernant des manières de voir qui divergent de la ligne officielle. Mais la disposition aux risques et l'énergie concrètement [et phénoménalement, *ndt*] engagée par les médecins marseillais [et leur patron formidable, *ndt*] font reconnaître ce que Rudolf Steiner appela en son temps « **le courage de guérir** ».[31]

***Die Drei* 5**/2020.

(Traduction Daniel Kmiecik)

---

[21] Voir la note **13** à la 5ème minute.

[22] www.orspaca.org/sites/default/files/Note-n3-confinement-masques-choloroquine-vaccin.pdf

[23] www.apotheke-adhoc.de/nachrichtent/detail.coronavirus/fda-gibt-chloroquine-fuer-kliniken-frei/

[24] www.mediterranee-infection.com/coronavirus-pays-ou-lhydroxychloroquine-est-redommandee/

[25] www.rts.ch/info.sciences-tech/11238116.la-majorite-des-patients-hospitalises-aux-hug-recoivent-de-la-chloroquine.html

[26] www.paris-match.com/Acu/Sante/Covid-19/-c-est-avoir-tort-que-d-avoir-raison-trop-tot-malheureusement-1680591

[27] www.welt.de/vermischtes/article206630043/Coronavirus-Bundesregierung-hat-grosessere-Mengen-von-moeglichem-medikament-gesichert.html

[28] Voir : www.businesswire.com/news/home/20200408005387/en/

[29] www.bundesaerztekammer.de/filedmin/user_upload/dowloads/pdfOrdner/Stellungnaghmen/MedBVSV_SN_BAEK_AkdAE_09042020_final.pdf

[30] Voir : www.suddeutsche.de/wissen/trump-coronavirus-hydrochloroquin-1.4869923 & www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/corona-trump-setzt-weiter-auf-malaria-medikament-16715430.html

[31] Rudolf Steiner : Connaissance anthroposophique de l'être humain et médecine (**GA 319**), Dornach 1994, p.29.